کانال اگر من طراح بودم@konkour2017



مرکز روانشناختی و آموزشی

هالی عباس

دکتر سام خانیان(مدیر دپارتمان آموزش و روانشناسی)

رتبه ۱ کارشناسی ارشد آزاد روانشناسی بالینی ۹۳: فروهنده گلیجانی
رتبه ۲ کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی ۹۳: آرزو ایشان زاده
رتبه ۳ کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی ۹۳: ملیحه طالبی
رتبه ۲ کارشناسی ارشد آزاد روانشناسی بالینی ۹۴: مرضیه کیوانی
رتبه ۲ کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی ۹۴: مهری عباسی
رتبه۳ کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روانشناسی بالینی ۹۴: معصومه بوالحسنی
رتبه ۶ کارشناسی ارشد آزاد روانشناسی بالینی ۹۴: فرزانه هاشم نژاد
رتبه ۱ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۴: سهیلا اعتمادی
رتبه ۶ دکتری آزاد روانشناسی عمومی ۹۴: پرستو تقوی
رتبه ۸ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۴: شیرین انصاری
رتبه ۹ دکتری سراسری روانشناسی ۹۴: سمانه بهزاد پور(بالینی شهید بهشتی)
رتبه ۱۲ دکتری سراسری روانشناسی ۹۴: معصومه درویشی لرد(سلامت دانشگاه تهران)
رتبه ۱ دکتری سراسری مشاوره ۹۵: احمد یوسف نژاد(دانشگاه علامه طباطبائی)
رتبه ۱ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: ماندانا مشعشعی(دانشگاه واحد تهران مرکز)
رتبه ۱ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: محمد آشنا(دانشگاه واحد کرج)
رتبه ۱ دکتری آزاد روانشناسی بالینی ۹۵: سحر ترابیان(دانشگاه واحد شیراز)
رتبه ۱ دکتری آزاد روانشناسی عمومی ۹۵: سید بهروز هاشمی(دانشگاه واحد علوم تحقیقات)
رتبه ۲ دکتری آزاد روانشناسی تربیتی ۹۵: فروغ طاهر سلطانی(دانشگاه واحد علوم تحقیقات)
رتبه ۲ دکتری آزاد مشاوره ۹۵: سحر سنندجی(دانشگاه واحد علوم تحقیقات)
رتبه ۳ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: زهرا کریمیان(دانشگاه واحد کرج)
رتبه ۳ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: طلا اسداللهی(دانشگاه واحد تهران مرکز)
رتبه ۴ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: مهسا مقدم(دانشگاه واحد تهران مرکز)
رتبه ۶ دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۹۵: شهره شمیرانی(دانشگاه واحد کرج)
رتبه ۶ دکتری آزاد روانشناسی عمومی ۹۵: مهتاب نوروزیان(دانشگاه واحد علوم تحقیقات)

Halyabbascenter.com



جـــزوه طـــلایی

نظریه های شخصیت

فیست (سید محمدی)

بـرگرفته از کلاس ویـژه کنکـور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

مؤلفـــان:

مـــاندانـا مشعـشعی

اسحـاق سام خانیان

مهدی محمدخانی

با هالی باشید تا بدرخشید....

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و محتوی دارد

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فصل اول: مفاهیم و کلیات روانشناسی رشد(تعریف و هدف رشد با نظریه های دیدگاه عمر، نظریه فرم یافتگی پیشین(پیش ساختگی)، لاک، روسو، دیوئی، مونته سوری و .....) ۵
فصل دوم: فروید: نظریه روان‌کاوی ۹
فصل سوم: الفرد آدلر: روان‌شناسی فردنگر ۱۹
فصل چهارم: کارل گوستاوز یونگ: روان‌شناسی تحلیلی ۲۷
فصل پنجم: ملانی کلین: نظریه روابط شیء ۳۶
فصل ششم: کارن هورنای: نظریه روان‌کاوی اجتماعی ۴۳
فصل هفتم: اریک فروم: روان‌کاوی انسان‌گرا ۵۴
فصل هشتم: اریکسون: نظریه پسافردی ۶۲
فصل نهم: مزلو: نظریه کل‌نگر- پویشی ۶۷
فصل دهم: کارل راجرز: نظریه فردمدار ۷۲
فصل یازدهم: رولومی: روان‌شناسی وجودی ۷۹
فصل دوازدهم: آلپورت: روان‌شناسی فردی ۸۳
فصل سیزدهم: مک کری وکاستا ۸۸
فصل چهاردهم: آیزنک: نظریه‌های عاملی ۹۰
فصل پانزدهم: باس:نظریه تکاملی شخصیت ۹۲
فصل شانزدهم: اسکینر: تحلیل رفتاری ۹۴
فصل هفدهم: بندورا: نظریه اجتماعی- شناختی ۱۰۱

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

فصل هجدهم: راتر و میشل: نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی ۱۰۷

فصل نوزدهم: کلی: روان‌شناسی سازه‌های شخصی ۱۱۳

فصل بیستم: سالیوان: نظریه میان فردی ۱۱۷

کانال اگر من طراح بودم@konkour2017

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و محتوی دارد

فصل بیستم : نظریه‌ی میان فردی هاری استاک سالیوان

- سالیوان معتقد بود افراد شخصیت خود را در بستر اجتماعی پرورش می‌دهند. او باور داشت که انسان‌ها بدون افراد دیگر هیچ شخصیتی نخواهند داشت. سالیوان تأکید داشت آگاهی از شخصیت انسان را فقط می‌توان از طریق بررسی علمی روابط میان فردی به دست آورد.
- نظریه‌ی میان فردی او بر اهمیت مراحل مختلف رشد تأکید دارد. رشد سالم انسان به توانایی فرد در برقراری رابطه‌ی صمیمانه با فردی دیگر وابسته است و اضطراب می‌تواند در هر سنی در روابط میان فردی رضایت‌بخش اختلال ایجاد کند. عمده‌ی کارهای سالیوان با افراد اسکیزوفرنیک بود.

مفاهیم اصلی

تنش‌ها (پتانسیل برای عمل کردن)

- سالیوان نیز مانند فروید و یونگ شخصیت را به صورت یک سیستم انرژی در نظر داشت. تغییر شکل‌های انرژی، تنش‌ها را به رفتارهای نا آشکار یا آشکار تبدیل می‌کند و هدف آن‌ها ارضا کردن نیازها و کاهش دادن اضطراب است. تنش، احتمال عمل کردن است که امکان دارد در آگاهی تجربه شود یا نشود بنابراین همه‌ی تنش‌ها به صورت هشیار احساس نمی‌شوند. تنش‌ها تا اندازه‌ای تحریف واقعیت‌اند. دو نوع تنش وجود دارد: نیازها و اضطراب.

نیازها

- نیازها تنش‌هایی هستند که عدم تعادل زیستی بین فرد و محیط فیزیو- شیمیایی درون و بیرون از ارگانیزم آن‌ها را به بار می‌آورد نیازها گذرا و عنصر زیستی هستند. اساسی‌ترین نیاز میان فردی محبت است و محبت نیاز کلی است. نیازهای کلی، میان فردی و فیزیولوژیک هستند. نیازهای موضعی که می‌توانند نیازهای کلی را ارضا کنند به منطقه‌ی خاصی از بدن مربوط می‌شوند، مثل دهان، تناسل و دست و ...

اضطراب

- اضطراب گسسته، پراکنده و مبهم است، اضطراب از طریق فرایند همدلی از مادر به کودک منتقل می‌شود. اضطراب در ارضای نیازها اختلال ایجاد می‌کند.

پویش‌ها

- تغییر شکل‌های انرژی به صورت الگوهای رفتار عادی که فرد را در طول عمر مشخص می‌کنند، سازمان می‌یابد که سالیوان این الگوهای رفتار را پویش‌ها نامید. (تقریباً به معنی صفات یا عادات است). پویش‌ها دو طبقه‌ی اساسی هستند: طبقه‌ی اول آن‌هایی هستند که به مناطق خاص بدن، از جمله دهان، مقعد و اندام‌های

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

تناسلی مربوط می‌شوند. طبقه‌ی دوم آن‌هایی هستند که با تنش‌ها ارتباط دارند و از سه طبقه تشکیل شده‌اند. پویش‌های گسسته، مجزا، پیوسته.

بدخواهی (Malevolence)

- بدخواهی پویش گسسته‌ی شرارت و نفرت است که با احساس زندگی کردن در بین دشمنان مشخص می‌شود. بدخواهی در حدود ۲ و ۳ سالگی ایجاد می‌شود. اعمال بدخواهانه اغلب به صورت کمرویی، مودی گری، قساوت و رفتارهای ضداجتماعی درمی‌آید. این پویش تمام الگوهای رفتار مخرب را در برمی‌گیرد.

صمیمیت (پویش پیوسته)

- صمیمیت از نیاز پیشین به محبت به وجود می‌آید، اما اختصاصی‌تر است و رابطه‌ی میان فردی بین دو نفر را شامل می‌شود که مرتبه‌ی کم و بیش برابری دارند. صمیمیت قبل از بلوغ و به صورت ایده آل در دوره‌ی پیش نوجوانی ایجاد می‌شود. صمیمیت، پویشی منسجم کننده است که واکنش‌های محبت‌آمیز طرف مقابل را برمی‌انگیزد و اضطراب و تنهایی را کاهش می‌دهد.

شهوت (lust)

- شهوت پویشی مجزاست و برای ارضای آن به فرد دیگری نیاز نیست. پویشی قدرتمند در مرحله جوانی است که با محافظت کردن از افراد در برابر اضطراب، امنیت میان فردی آن‌ها را تأمین می‌کند و از موقعیت میان فردی ناشی می‌شود. تقریباً در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی پرورش می‌یابد.
- افراد سعی می‌کنند به‌وسیله‌ی عملیات امنیتی از خودشان در برابر تنش‌های میان فردی دفاع کنند. هدف عملیاتی امنیتی مهم، تجزیه و بی‌توجهی گزینشی هستند. تجزیه شامل آن دسته از تکانه‌ها، امیال و نیازهایی است که فرد به آن‌ها اجازه نمی‌دهد وارد آگاهی شوند. تصورات تجزیه‌شده در رویاها، خیال‌بافی‌ها و سایر فعالیت‌های غیر عمدی بیرون از آگاهی آشکار می‌شوند و هدف آن‌ها حفظ کردن امنیت میان فردی است.
- کنترل تمرکز آگاهی که بی‌توجهی گزینشی نامیده می‌شود، خودداری از دیدن چیزهایی است که فرد دوست ندارد آن‌ها را ببیند. برخلاف تجزیه کار به طور ناآگاه است، این بی‌توجهی‌ها در دسترس آگاهی قرار دارند. ازنظر گسترده محدودتر هستند و بعدازاین که افراد سیستم خود را تشکیل دادند، آغاز می‌شوند.

شخصیت بخشی‌ها (personification)

- در آغاز نوباوگی و بعد در طول مراحل گوناگون رشد، افراد تصورات خاصی را از خود و دیگران کسب می‌کنند، این تصورات که شخصیت بخشی نامیده می‌شوند، می‌توانند نسبتاً دقیق باشند یا شدیداً تحریف شده باشند، سالیوان سه شخصیت بخشی را توصیف کرد که در مدت نوباوگی ایجاد می‌شوند.

۱- شخصیت بخشی مادر بد، مادر خوب

- شخصیت بخشی مادر بد: این شخصیت بخشی از تجربیات کودک درمورد نوک پستان بد ناشی می‌شود. یعنی نوک پستانی که نیازهای گرسنگی را ارضا نمی‌کند این تجربه صرفاً بازنمایی مبهم کودک از درست تغذیه نشدن

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

بخشی از هزینه‌های جزوات صرف حمایت از کودکان بی سرپرست خواهد شد

است. بعد از اینکه شخصیت بخشی مادر بد تشکیل شد، کودک بر اساس رفتارهای محبت‌آمیز مادر، شخصیت بخشی مادر خوب را فرا می‌گیرد.

۲- شخصیت بخشی‌های من

- کودک در اواسط نوباوگی، سه شخصیت بخشی من را اکتساب می‌کند.
- **شخصیت بخشی منِ بد** از تجربیات تنبیه شدن و تائید نشدن کودکان از جانب مادرشان شکل می‌گیرد. منِ بد مانند همه‌ی شخصیت بخشی‌ها از موقعیت میان فردی شکل می‌گیرد.
- **شخصیت بخشی منِ خوب** از تجربیات کودکان در رابطه با پاداش و تائید ناشی می‌شوند.
- **شخصیت بخشی منِ هیچ** از اضطراب شدید یا ناگهانی به وجود می‌آید و تجربیات مرتبط با آن اضطراب را تجزیه نموده یا به صورت گزینشی به آن توجه نمی‌کند. زمانی که بزرگسالان دچار اضطراب شدید و ناگهانی می‌شوند، هیجان غیر عادی (uncanny emotion) بر آن‌ها چیره می‌شود. با این که این تجربه افراد را در روابط میان فردی‌شان عاجز می‌کند، اما علامت با ارزشی برای واکنش‌های اسکیزوفرنیک قریب‌الوقوع است.

۳- شخصیت بخشی‌های خیالی (eidetic personalification)

- همه‌ی روابط میان فردی با افراد واقعی نیستند. کودکان اغلب همبازی‌های خیالی دارند، یعنی صفات یا افراد غیر واقعی که کودکان برای حفاظت از عزت نفسشان می‌آفرینند. این دوستان خیالی به اندازه‌ی همبازی‌های واقعی برای کودک اهمیت دارند.

سطوح شناخت

- سطوح شناخت به روش‌های درک کردن، تخیل کردن و تصور کردن اشاره دارند. سالیوان سه سطح شناخت را مشخص کرد که عبارت‌اند از: ابتدایی اندیشی، علت و معلول اندیشی صوری و عینی اندیشی.

۱- سطح ابتدایی اندیشی (prototaxic)

- ابتدایی‌ترین تجربیات کودک در این سطح صورت می‌گیرند. این تجربیات را نمی‌توان به دیگران انتقال داد و به صورت کامل ناهشیارند. نوزاد احساس گرسنگی و درد می‌کند و این تجربیات ابتدایی به عمل قابل مشاهده‌ای نظیر مکیدن یا گریه کردن منجر می‌شوند. کودک دلیل این اعمال را نمی‌داند و بین آن‌ها هیچ رابطه‌ای نمی‌بیند.

۲- سطح علت و معلول اندیشی صوری (paratixic)

- تجربیات در این سطح پیش منطقی هستند و زمانی ایجاد می‌شوند که فرد بین دو رویدادی که برحسب اتفاق با هم روی داده‌اند، رابطه‌ی علت و معلولی فرض می‌کند. معنی این تجربیات شخصی است و فقط به صورت تحریف شده می‌توان آن‌ها را به دیگران انتقال داده تجربیات شرطی کردن انسان‌ها و حیوان‌ها، نمونه‌ای از علت و معلول اندیشی صوری است.

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

بخشی از هزینه‌های جزوات صرف حمایت از کودکان بی سرپرست خواهد شد

۳- سطح منطقی اندیشی (syntaxic)

- تجربیاتی که از نظر عموم معتبر هستند و می‌توان آن‌ها را به صورت نمادی به دیگران انتقال داد. در این سطح صورت می‌گیرند. این تجربیات آن‌هایی هستند که دو نفر یا بیشتر درباره‌ی معنی آن‌ها اتفاق نظر دارند. رایج‌ترین نمادهایی که یک نفر برای ارتباط برقرار کردن با دیگری به کار می‌برد، نمادهای زبان، از جمله کلمات و ایما و اشاره هستند. این سطوح زمانی رایج‌تر می‌شود که کودک زبان رسمی را آغاز کند.

مراحل رشد

- سالیوان هفت مرحله‌ی رشد را فرض کرد که روابط میان فردی در تمام این مراحل جریان دارند. تعبیر شخصیت می‌تواند در هر زمانی روی دهد اما هنگام انتقال از یک مرحله به مرحله‌ی بعدی، احتمال آن خیلی بیشتر است. در واقع این دوره‌های ورودی از خود مراحل مهم‌تر هستند.

نوباوگی

- نوباوگی از تولد شروع می‌شود و تا زمانی که کودک معمولاً در ۱۸ تا ۲۴ ماهگی به صورت شمرده صحبت کند، ادامه می‌یابد. اولین اضطراب کودک همیشه با وضعیت پرستاری و منطقه‌ی دهانی ارتباط دارد. کودک اضطراب و گرسنگی را از طریق گریه ابراز می‌کند. با افزایش تنش، کودک توانایی ارضا شدن را از دست می‌دهد. هنگامی که نیاز به غذا همچنان افزایش پیدا می‌کند. تنش کودک به وحشت می‌رسد. محافظ‌های فطری بی‌تفاوتی و خواب آور (apathy and somnolent detachment) کودک را از مرگ نجات می‌دهند، این محافظ‌ها به کودک امکان می‌دهند، به رغم گرسنگی به خواب رود.
- نوباوگان در اواسط نوباوگی یاد می‌گیرند از طریق زبان ارتباط برقرار کنند. این دوره از نوباوگی با زبان اوتیستیک (autistic language) مشخص می‌شود؛ یعنی زبان خصوصی‌ای که برای دیگران معنی چندانی ندارد.

کودکی

- این مرحله با پیدایی زبان نحوی آغاز می‌شود و تا ظاهر شدن نیاز به همبازی‌های هم‌مرتبه ادامه می‌یابد. این دوره از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی الی ۵ تا ۶ سالگی را در برمی‌گیرد. در این مرحله شخصیت بخشی‌های مادر خوب و مادر بد معمولاً در سطح علت و معلول اندیشی صوری حفظ می‌شوند. اکنون کودک به تقلید از والدین به رفتارها برچسب خوب و بد می‌زند.
- در مرحله‌ی کودکی هیجانات دو جانبه می‌شوند، کودک می‌تواند صحبت کند و محبت ببیند. در این مرحله کودکان پیش‌دبستانی یک رابطه‌ی مهم با همبازی‌های خیالی دارند. سالیوان کودکی را دوره فرهنگ پذیری سریع نامید.
- کودکان علاوه بر فراگیری زبان، الگوهای فرهنگی پاکیزگی، آموزش استفاده از توالت، عادت‌های خوردن و انتظارات نقش جنسی را یاد می‌گیرند. آن‌ها همچنین دو فرایند مهم دیگر را یاد می‌گیرند: نمایشات (dramatization) و اشتغال‌های ذهنی (preoccupation).

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

بخشی از هزینه‌های جزوات صرف حمایت از کودکان بی سرپرست خواهد شد

- نمایشات تلاش‌هایی برای عمل کردن شبیه صاحبان قدرت مهم، مخصوصاً پدر و مادر هستند. اشتغال ذهنی راهبردهایی هستند برای اجتناب کردن از اضطراب و موقعیت‌های ترس‌انگیز به وسیله‌ی مشغول نگهداشتن خود به فعالیتی که قبلاً سودمندی یا تقویت‌کنندگی آن‌ها ثابت شده است. نگرش بدخواهانه در این سال‌ها به اوج می‌رسد.

دوران بچگی

- دوران بچگی با پیدایی نیاز به همسالان یا همبازی‌های هم‌مرتبه آغاز می‌شود و به زمانی ختم می‌شود که کودک رفیقی را برای ارضا کردن صمیمیت پیدا می‌کند. این دوران تقریباً از ۵ یا ۶ ماهگی شروع شده و به ۸/۵ سالگی ختم می‌شود. کودک در این دوره، باید رقابت کردن، سازش کردن و همکاری کردن را یاد بگیرد. در پایان این دوره کودک باید جهت‌گیری به سمت زندگی را پرورش داده باشد.

پیش نوجوانی

- پیش نوجوانی از ۸/۵ سالگی شروع و به نوجوانی ختم می‌شود. دوره‌ی صمیمیت با یک فرد به‌خصوص، معمولاً فردی هم‌جنس است که از لحاظ سنی یا مقام اجتماعی تقریباً برابر است. همه‌ی مراحل پیشین خودمحورانه هستند، به‌طوری که روابط دوستی بر اساس نفع شخصی برقراری می‌شوند. پیش نوجوانی برای اولین بار، به فرد دیگری علاقه‌ی واقعی پیدا می‌کند. ویژگی بارز این دوره پیدایش قابلیت دوست داشتن است. در این دوره صمیمیت و عشق اساس دوستی‌ها می‌شوند. به اعتقاد سالیوان پیش نوجوانی بی‌دردسرترین و بی‌خیال‌ترین دوره زندگی است. به نظر سالیوان شادی این مرحله مهم‌ترین مرحله‌ی رشد باشد.

اوایل نوجوانی ۱۳ تا ۱۵ سالگی

- اوایل نوجوانی با بلوغ شروع می‌شود و به نیاز به عشق جنسی با یک نفر، خاتمه می‌یابد. این دوره با فوران تمایل تناسلی و پیدایی روابط شهوت‌انگیز مشخص می‌شود. در این دوره صمیمیت، امنیت و شهوت باهم تعادل پیدا می‌کنند. چون پویش شهوت زیستی است به هنگام بلوغ پدیدار می‌شود. نوجوان با چند رفیق رابطه دارد و نسبت به آن‌ها صمیمیت و شهوت پیدا می‌کند.

اواخر نوجوانی

- اواخر نوجوانی زمانی آغاز می‌شود که جوانان می‌توانند نسبت به یک نفر احساس شهوت و صمیمیت داشته باشند و به بزرگسالی که رابطه‌ی عشقی بادوامی برقرار می‌کنند، ختم می‌شود. ویژگی بارز این دوره ترکیب صمیمیت و شهوت است. اواخر نوجوانی موفقیت‌آمیز با رشد شیوه‌ی منطقی اندیشی مشخص می‌شود.

بزرگسالی

- در این دوره افراد می‌توانند با حداقل یک نفر رابطه‌ای عاشقانه برقرار کنند. این رابطه عاشقانه شاید منبع اصلی رضایت در زندگی باشد. بزرگسالان پخته اضطراب و امنیت دیگران را درک می‌کنند، نسبت به نیازهای آن‌ها حساس‌اند، اضطراب کمی دارند و در سطح منطقی اندیشی عمل می‌کنند.

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و معنوی دارد

روان‌درمانی

- چون سالیوان معتقد بود اختلال‌های روانی از مشکلات میان فردی ناشی می‌شوند، روش‌های درمانی خود را بر پایه‌ی بهبود بخشیدن به رابطه‌ی بیمار با دیگران قرار داد. هدف درمان سالیوان به طور کلی این است که مشکلات بیماران را در برقرار کردن رابطه با دیگران برملا کند. عنصر درمانی در این فرایند رابطه‌ی رودررو بین درمانگر و بیماران است.
- هانس استراپ و ویلیام هنری برای اینکه ببینند چگونه پویش‌های میان فردی بین بیمار و درمانگر بر موقعیت درمان تأثیر می‌گذارند، از بررسی ساختار رفتار اجتماعی (SASB) لورنا اسمیت بنجامین استفاده کرده‌اند.
- SASB از سه جنبه به رفتار میان فردی می‌پردازد:
- **تمرکز بر دیگران:** یا رفتار عادی فرد هنگامی‌که با فرد دیگری رابطه برقرار می‌کند.
- **تمرکز بر خود:** یا واکنش‌های عادی فرد نسبت به رفتار فردی دیگر.
- **درون‌فکنی:** یا برگرداندن به درون و فکر کردن به نحوه‌ای که افراد مهم با فرد برخورد کرده‌اند.
- SASB به پژوهشگران امکان می‌دهد روابط میان فردی را لحظه به لحظه بررسی کنند و ببینند درمانگر در عمل برای تقویت کردن یا ممانعت کردن از پیشرفت درمان چه کاری انجام می‌دهد.

کانال اگر من طراح بودم
@konkour2017
مهدی محمدخانی

هر گونه کپی و استفاده از جزوه بدون هماهنگی مؤلفان دین الهی و محتوی دارد

بخشی از هزینه‌های جزوات صرف حمایت از کودکان بی سرپرست خواهد شد